ORIGEM DO DOCUMENTO:	UTI ADU – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO		
TÍTULO:			**Nº DOC:**
PLANO TERAPEUTICO			FRM.UTIADU.003
DATA 1ª VERSÃO	**DATA DESTA VERSÃO**	**VERSÃO Nº**	**PRÓXIMA REVISÃO**
19/12/2025	19/12/2025	001	19/12/2027

1. OBJETIVO

1.1. Estabelecer diretrizes para elaboração, registro, acompanhamento e reavaliação do Plano Terapêutico (PT) dos pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva, assegurando cuidado sistematizado, contínuo, individualizado, seguro e alinhado às melhores práticas assistenciais, à segurança do paciente e à padronização institucional.

2. ABRANGÊNCIA

2.1. Esta ferramenta aplica-se a todos os pacientes admitidos na Unidade de Terapia Intensiva da FCECON, independentemente da patologia de base, bem como a todos os profissionais envolvidos na assistência, utilizando prontuário eletrônico ou físico institucional, em regime de internação.

3. IMPORTANCIA

3.1. A passagem de plantão médica na UTI é etapa obrigatória do cuidado intensivo. Devido à instabilidade clínica dos pacientes e à necessidade de decisões rápidas, a transmissão clara, objetiva e padronizada das informações é essencial para prevenir falhas de comunicação e eventos adversos, assegurando a manutenção das condutas terapêuticas e a priorização adequada dos casos críticos.

4. PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS E RESPONSÁVEIS

4.1. Compete ao médico intensivista ou médico assistente responsável pelo paciente:

- Elaborar o Plano Terapêutico inicial em até 6 (seis) horas após a admissão na UTI;
- Definir o diagnóstico principal e diagnósticos associados, com registro de CID-10;
- Estabelecer objetivos terapêuticos claros e mensuráveis;
- Prescrever e revisar as condutas terapêuticas medicamentosas e não medicamentosas;
- Garantir a reavaliação diária do Plano Terapêutico ou sempre que houver mudança clínica relevante;
- Registrar as decisões no prontuário eletrônico de forma clara, objetiva e rastreável;
- Integrar o plano às ações da equipe multiprofissional;
- Planejar e registrar critérios de progressão, desmame, alta da UTI ou transferência de unidade.

5. DESCRIÇÃO DA ROTINA E PROCEDIMENTO

5.1. Abertura do Plano Terapêutico

- Realizar o registro no prontuário eletrônico em até **6 horas da admissão** na UTI;
- Confirmar identificação do paciente e data/hora automáticas do sistema

5.2. Definição Diagnóstica

- Registrar o **diagnóstico principal** (CID-10);
- Identificar diagnósticos associados e disfunções orgânicas presentes;
- Correlacionar dados clínicos, laboratoriais e de imagem.

5.3. Definição dos Objetivos Terapêuticos

Estabelecer objetivos de curto e médio prazo, tais como:

- Estabilização hemodinâmica;
- Manutenção de oxigenação e ventilação adequadas;
- Suporte de órgãos disfuncionais;
- Tratamento da causa base;
- Prevenção de complicações relacionadas à terapia intensiva;
- Planejamento de desmame e alta da UTI.

5.4. Planejamento das Condutas

Registrar de forma estruturada:

- Tratamento medicamentoso (integrado à prescrição eletrônica);
- Medidas não farmacológicas;
- Suporte ventilatório e hemodinâmico;
- Monitorização clínica e laboratorial;
- Medidas de segurança do paciente (profilaxias, prevenção de eventos adversos).

5.5. Monitorização e Exames

- Definir exames complementares necessários;
- Determinar frequência de monitorização clínica e parâmetros-alvo;
- Registrar metas terapêuticas quando aplicável.

5.6. Reavaliação Diária

- Realizar reavaliação **diária obrigatória** do Plano Terapêutico;
- Registrar evolução clínica e necessidade de ajustes;
- Documentar resposta ao tratamento ou falha terapêutica.

5.7. Planejamento de Alta ou Transferência

- Avaliar critérios clínicos para progressão do cuidado;
- Registrar planejamento de alta da UTI ou transferência para enfermaria;
- Atualizar o Plano Terapêutico conforme novo nível assistencial.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 O Plano Terapêutico é documento obrigatório no prontuário do paciente crítico.

6.2 . A ausência ou preenchimento inadequado configura não conformidade assistencial infligindo as diretrizes institucionais e normativas vigentes.

7. REFERÊNCIAS

7.1. **BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).** Resolução RDC nº 7, de 24 de fevereiro de 2010. Dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva.

7.2. **BRASIL. Ministério da Saúde.** Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013.

7.**3. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).** Documento de Referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Brasília: ANVISA, 2014.

7.**4. Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).** Diretrizes Brasileiras de Terapia Intensiva. São Paulo: AMIB.

7.5. **Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM).** Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas aplicáveis ao paciente hospitalizado crítico.

7.**6 World Health Organization (WHO).** Patient Safety: Global Action Plan 2021–2030. Geneva: WHO.

8. ANEXO

8.1. Anexo 1- Plano terapêutico

PLANO TERAPEUTICO		
SEÇÃO I: METAS SMART (PRÓXIMAS 24H/48H)		
Objetivo SMART (Mensurável)	Prazo Alvo (Data/Hora)	Status Atual
SEÇÃO II: ALTA DA UTI (CRITÉRIOS)		
Critérios	**Status**	**Atingido (S/N)**
1. Sem Vasopressor (≥24h)		
2. Sem VM Invasiva (≥24h)		
3. Necessidade de Monitoramento Complexo		
Previsão de Alta para Enfermaria:		

7. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
001	19/12/2025	Versão Inicial

Elaboração: Edgar da Silva Pereira – Coordenador Médico Assinatura: gov.br Documento assinado digitalmente EDGAR DA SILVA PEREIRA Data: 19/12/2025 13:47:48-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Data: 18/12/2025
Aprovação: Hilka Flavia do Espirito Santo – DITEC Assinatura: HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253 Assinado de forma digital por HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253	Data: 18/12/2025